

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO	2
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	2
1.3 IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE	2
1.3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA ENTIDADE	3
2. RESUMO DO PROJETO	3
3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO	4
3.1. Contextualização	5
3.2. Justificativa.....	9
4. OBJETIVOS E METAS	11
4.1. Objetivo Geral.....	11
4.2. Objetivos Específicos	12
4.3. Metas Do Projeto	14
5. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO	15
6. CRONOGRAMA MENSAL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES POR META	25
7. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO	29
7.1. Execução Direta do Projeto.....	29
7.2. Despesas Administrativas e Operacionais.....	30
7.3. Custo Total do Projeto.....	31
8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	31
9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS	32
9.1. Resultados Esperados	33
9.2. Impactos Esperados.....	35
10. CONSIDERAÇÕES GERAIS	37
11. LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO.....	41
12. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	42
13. FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO – TERMO DE PARCERIA Nº 001/2026.....	51



. IDENTIFICAÇÃO

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal

Instrumento Jurídico: Termo de Parceria

Forma de Celebração: Dispensa de Concurso de Projetos, nos termos da Lei Federal nº 9.790/1999, Decreto Federal nº 3.100/1999 e Lei Estadual nº 11.082/2020.

Órgão Concedente: Prefeitura Municipal de Dom Aquino/MT

Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público: Organização de Saúde São Bento

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias

Local de Execução: Município de Dom Aquino/MT

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome: Organização de Saúde São Bento

CNPJ: 45.603.168/0001-20

Endereço: Rua Trinta e Seis, 119, Lote 10 Quadra 05, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, CEP 78.068-417

e-mail: organizacaodesaudeaobento@gmail.com

Tipo de Proponente: OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE

Nome: Iredir Maria Laccal da Silva Ferreira

RG: 1670903-9 SSP/MT

CPF: 983.223.111-68

Cargo: Presidente

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA ENTIDADE

Nome: Iredir Maria Laccal da Silva Ferreira

RG: 1670903-9 SSP/MT

CPF: 983.223.111-68

Cargo: Presidente

2. RESUMO DO PROJETO

O Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal tem como finalidade fortalecer a capacidade técnica, assistencial, administrativa, operacional e logística da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Aquino/MT, contribuindo para a continuidade, a organização e a qualificação dos serviços ofertados à população no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

A proposta contempla a execução complementar de atividades voltadas ao funcionamento da rede municipal de saúde, incluindo apoio às unidades assistenciais, organização dos fluxos de atendimento, realização de atendimentos médicos e multiprofissionais, cobertura de plantões, suporte às ações da Atenção Primária à Saúde, apoio às atividades administrativas, assistenciais, técnicas, operacionais e logísticas e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados.

As ações serão desenvolvidas de forma integrada à Secretaria Municipal de Saúde, observando-se as prioridades da gestão municipal, os fluxos assistenciais existentes, as demandas das unidades, os critérios de regulação, as metas pactuadas, os protocolos técnicos, as normas sanitárias e profissionais e os princípios da universalidade, integralidade, equidade, humanização e segurança do paciente.

A execução deverá contribuir para ampliar a capacidade de resposta da rede municipal, assegurar maior regularidade na oferta dos serviços, reduzir riscos de descontinuidade assistencial, organizar as escalas e os fluxos de atendimento e proporcionar melhores condições de acesso, acolhimento, acompanhamento e continuidade do cuidado aos usuários.

As atividades serão realizadas por profissionais com formação, habilitação, registro profissional e experiência compatíveis com as funções desempenhadas. Os atos privativos de cada categoria deverão respeitar os limites legais, técnicos, éticos e regulamentares aplicáveis.

O projeto compreenderá o apoio às atividades médicas, de enfermagem, técnicas, multiprofissionais, administrativas, operacionais e logísticas necessárias ao funcionamento das unidades e serviços municipais de saúde, conforme as demandas formalmente apresentadas pela Secretaria.

A execução poderá abranger atendimento aos usuários, apoio às equipes assistenciais, organização de agendas e escalas, recepção e orientação, registros em prontuários e sistemas, acompanhamento de pacientes, dispensação e controle de materiais, apoio ao transporte sanitário, limpeza, conservação e organização das unidades e demais atividades compatíveis com o objeto do projeto.

A produção assistencial deverá ser registrada por meio dos instrumentos próprios da rede municipal e dos sistemas de informação aplicáveis, observando-se o sigilo profissional, a proteção dos dados pessoais e as normas de segurança da informação.

A atuação da entidade parceira terá natureza complementar, transitória e orientada por resultados, não implicando transferência da gestão municipal da saúde, substituição das competências decisórias da Secretaria, cessão de pessoal ou subordinação direta dos profissionais à Administração Pública Municipal.

O projeto prevê, ainda, a implantação e o aprimoramento de mecanismos de planejamento, registro, controle, acompanhamento e monitoramento das atividades, permitindo identificar os serviços executados, os atendimentos realizados, os profissionais mobilizados, as escalas cumpridas, as unidades apoiadas, as intercorrências e os resultados produzidos.

O acompanhamento da execução ocorrerá continuamente, mediante planejamento, escalas, registros assistenciais e operacionais, relatórios periódicos, indicadores de produção e resultado, fiscalização e validação pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ao término dos 180 dias, espera-se que a Secretaria Municipal de Saúde disponha de melhores condições técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas para manter a continuidade dos serviços, ampliar a capacidade de atendimento da rede e prestar assistência mais organizada, humanizada, segura e resolutiva à população de Dom Aquino/MT.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

3.1. Contextualização

A saúde constitui direito social fundamental e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas destinadas à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. A Constituição Federal estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde – SUS, organizado segundo as diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.

O Município de Dom Aquino, localizado no Estado de Mato Grosso, possui código IBGE nº 5103601, área territorial de 2.183,603 km², população de 7.872 habitantes no Censo Demográfico de 2022, densidade demográfica de 3,61 habitantes por quilômetro quadrado e população estimada em 7.890 habitantes em 2025. A extensão territorial, associada à distribuição da população entre a sede urbana e as localidades rurais, exige capacidade permanente de planejamento, deslocamento, organização assistencial e manutenção de serviços em diferentes pontos do território municipal.

Essa configuração territorial repercute diretamente na organização da rede municipal de saúde, especialmente quanto à necessidade de assegurar acesso à Atenção Primária, atendimento médico, assistência de enfermagem, serviços multiprofissionais, assistência farmacêutica, reabilitação, transporte sanitário, vigilância em saúde, atendimentos de urgência e demais ações necessárias à continuidade do cuidado.

A Secretaria Municipal de Saúde exerce papel central na coordenação do sistema municipal, na definição das prioridades sanitárias, na organização dos serviços, no planejamento das ações, na regulação do acesso, no acompanhamento dos indicadores, na articulação entre as unidades e na integração do Município com a rede regionalizada do SUS.

A rede vinculada à gestão municipal de saúde de Dom Aquino/MT é composta por 11 estabelecimentos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, abrangendo unidades de gestão, regulação, Atenção Primária, atenção hospitalar, reabilitação, assistência farmacêutica e atendimento à população idosa.

Essa composição demonstra que a rede municipal possui diferentes pontos de atenção e estruturas complementares, exigindo articulação permanente entre a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, a Central Municipal de Regulação, as unidades de Saúde da Família, as unidades rurais, o Centro de Saúde, o Hospital Municipal, o Centro de Reabilitação, a Farmácia Básica e os demais serviços cadastrados.

CNES	Estabelecimento
------	-----------------

7859023	Central Municipal de Regulação de Dom Aquino
2395940	Centro de Reabilitação Ariston Delmondes da Silva
2395975	Unidade de Saúde Rural Entre Rios – Equipe 03
2699346	Unidade de Saúde da Família Vila Esportiva – Equipe 02
2395967	Unidade de Saúde da Família Vila Planaltina – Equipe 01
3961672	Unidade de Saúde Rural Geni Ferreira Barbosa – Equipe 04
2395959	Centro de Saúde de Dom Aquino
6295835	Secretaria Municipal de Saúde de Dom Aquino
4166639	Farmácia Básica de Dom Aquino
4245849	Tome da Silva Guedes – Casa dos Idosos de Dom Aquino
5632323	Hospital Municipal Dr. Lourival Cândido Portuguez

A presença de unidades urbanas e rurais evidencia a necessidade de organização territorializada dos serviços, de manutenção das escalas profissionais, de transporte e deslocamento das equipes, de abastecimento das unidades, de articulação entre os diferentes pontos da rede e de adequado registro da produção assistencial.

A Central Municipal de Regulação desempenha função relevante na organização do acesso, no encaminhamento dos usuários e na articulação entre os serviços municipais e os demais pontos da rede regionalizada. As unidades de Saúde da Família e as unidades rurais representam importantes portas de entrada do SUS no território, responsáveis pelo acompanhamento longitudinal da população, pelas ações de promoção e prevenção e pela coordenação do cuidado.

O Hospital Municipal constitui referência local para os atendimentos compatíveis com sua capacidade instalada, enquanto o Centro de Reabilitação, a Farmácia Básica e a unidade destinada ao atendimento da população idosa complementam a rede municipal, ampliando a oferta de cuidados e serviços especializados dentro das competências locais.

A estrutura municipal descrita demonstra a necessidade de articulação permanente entre as unidades de Atenção Primária, o hospital municipal, os serviços de reabilitação, a gestão da Secretaria e os demais pontos de atenção. Essa integração é indispensável para organizar o acolhimento, o atendimento, os encaminhamentos, o acompanhamento dos usuários e a continuidade do cuidado.

A Atenção Primária à Saúde deve atuar como principal porta de entrada e centro de comunicação da rede, responsabilizando-se pelo acompanhamento territorial da população, pela coordenação do cuidado e pela articulação com os demais serviços. A

Política Nacional de Atenção Básica estabelece diretrizes para a organização das unidades, das equipes e dos processos de trabalho da Atenção Básica no âmbito do SUS.

O funcionamento adequado da rede municipal depende da disponibilidade articulada de profissionais médicos, de enfermagem, técnicos, agentes comunitários, profissionais de reabilitação, equipes multiprofissionais, trabalhadores administrativos, recepcionistas, motoristas, profissionais de apoio e demais atividades necessárias à continuidade dos serviços.

Além dos atendimentos assistenciais, são necessárias rotinas permanentes de organização de agendas e escalas, acolhimento, recepção, registro de usuários, alimentação dos sistemas de informação, organização de prontuários, controle de materiais e medicamentos, transporte sanitário, limpeza e higienização das unidades, manutenção dos ambientes e acompanhamento dos indicadores de produção e qualidade.

A diversidade das demandas, a necessidade de cobertura das escalas e plantões, os afastamentos, as variações do fluxo assistencial e a dispersão territorial das unidades podem comprometer a continuidade dos serviços quando não há estrutura suficiente para mobilizar, coordenar, acompanhar e substituir tempestivamente os profissionais necessários.

A interrupção ou redução da capacidade assistencial poderá ocasionar aumento do tempo de espera, descontinuidade do acompanhamento, sobrecarga das equipes, fragilidade nos registros, dificuldades de acesso e prejuízos ao funcionamento das unidades. Por essa razão, torna-se necessário estabelecer mecanismos que preservem a regularidade dos serviços durante o período de transição.

A organização e a execução do projeto deverão observar a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, denominada Lei Orgânica da Saúde, que disciplina as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços integrantes do SUS. Essa legislação estabelece princípios como universalidade, integralidade, igualdade da assistência, descentralização, regionalização, hierarquização e utilização da epidemiologia para definição de prioridades.

Também deverá ser observada a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros, reconhecendo a atuação dos Conselhos e das Conferências de Saúde como elementos essenciais da governança do sistema.

O Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990 e disciplina a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência e a articulação interfederativa. O Decreto estabelece que a integralidade da assistência se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante o adequado encaminhamento e referenciamento dos usuários.

A aplicação dos recursos deverá observar a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta os valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde e estabelece regras de transparência, fiscalização, avaliação e controle das despesas realizadas pelos entes federativos.

As ações desenvolvidas nas unidades de Atenção Primária deverão observar a Política Nacional de Atenção Básica, consolidada nas normas do Ministério da Saúde, especialmente quanto à territorialização, à adscrição da população, ao acolhimento, ao vínculo, à longitudinalidade, à coordenação do cuidado e à integração das equipes com os demais pontos da rede.

A execução também deverá respeitar as normas de vigilância sanitária, biossegurança, prevenção e controle de infecções, gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, segurança do paciente, ética profissional, atendimento humanizado e exercício regular das profissões de saúde.

Os profissionais mobilizados deverão possuir formação, habilitação e registro ativo nos respectivos conselhos profissionais, quando exigidos. Os atos privativos de cada categoria deverão ser realizados exclusivamente por profissionais legalmente habilitados e dentro dos limites técnicos, éticos e regulamentares aplicáveis.

Os registros assistenciais deverão ser realizados nos prontuários, formulários e sistemas de informação definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, assegurando-se integridade, legibilidade, rastreabilidade, confidencialidade e disponibilidade das informações necessárias à continuidade do cuidado.

O tratamento de informações pessoais e dados de saúde deverá observar a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, considerando que dados referentes à saúde são classificados como dados pessoais sensíveis e demandam medidas específicas de segurança, prevenção de acessos não autorizados e utilização restrita às finalidades assistenciais e administrativas legítimas.

Nesse contexto, o Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal foi estruturado para apoiar, de forma complementar e temporária, a continuidade das atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas da rede municipal durante o período de 180 dias consecutivos e ininterruptos.

A proposta busca organizar o recebimento e a formalização das demandas, a estruturação das escalas e atividades, a mobilização dos profissionais, a execução dos atendimentos, o registro da produção, o acompanhamento das unidades e a consolidação mensal dos resultados alcançados.

As atividades serão executadas conforme as solicitações formalmente apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, as necessidades das unidades, a disponibilidade dos recursos, as atribuições referenciais dos profissionais, os protocolos assistenciais e as condições sanitárias, técnicas e de segurança aplicáveis.

A atuação da OSCIP terá natureza complementar, transitória e orientada pelo cumprimento das metas, sem transferência da gestão do SUS, da regulação assistencial, da definição das políticas de saúde, da autoridade sanitária, do poder de fiscalização ou das decisões administrativas reservadas ao Município.

Dessa forma, o Projeto FORSAÚDE deverá contribuir para o fortalecimento da capacidade técnica e operacional da Secretaria Municipal de Saúde, para a continuidade dos atendimentos, para a organização dos processos de trabalho e para a prestação de assistência mais acessível, segura, humanizada e resolutiva à população de Dom Aquino/MT.

3.2. Justificativa

A execução do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade, a regularidade e a qualidade das ações e dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Dom Aquino/MT durante o período de 180 dias consecutivos e ininterruptos.

A saúde constitui serviço público essencial e de caráter permanente, não admitindo interrupções que possam comprometer o acesso da população aos atendimentos, a continuidade dos tratamentos, o acompanhamento das condições de saúde, a assistência em situações de urgência e a execução das ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde.

A existência de unidades localizadas tanto na área urbana quanto na zona rural amplia a complexidade da organização municipal. A extensão territorial de Dom Aquino, a dispersão da população e as necessidades específicas das comunidades rurais demandam planejamento de deslocamentos, manutenção das escalas, transporte sanitário, abastecimento das unidades, organização dos atendimentos e disponibilidade de profissionais em diferentes localidades.

A Atenção Primária à Saúde representa a principal porta de entrada da população no SUS e desempenha papel fundamental na territorialização, no acolhimento, no acompanhamento das famílias, na prevenção de doenças, no controle das condições crônicas, na vacinação, na saúde materno-infantil, na vigilância e na coordenação do cuidado. A interrupção ou redução da capacidade das unidades poderá comprometer a continuidade do acompanhamento e aumentar a procura por serviços de maior complexidade.

O Hospital Municipal Dr. Lourival Cândido Portuguese também exerce função relevante na assistência local, especialmente quanto aos atendimentos compatíveis com sua capacidade instalada, plantões, observação, apoio diagnóstico e demais atividades hospitalares. A manutenção regular das escalas e do suporte técnico, assistencial, administrativo e operacional é indispensável para evitar descontinuidade dos atendimentos e sobrecarga dos demais pontos da rede.

A Central Municipal de Regulação possui importância estratégica para a organização do acesso, o encaminhamento dos usuários e a articulação entre os serviços municipais e regionais. Seu funcionamento adequado depende de registros atualizados, organização das solicitações, acompanhamento das agendas, orientação dos usuários e comunicação contínua entre as unidades solicitantes e os serviços de referência.

O Centro de Reabilitação, a Farmácia Básica, o Centro de Saúde, as unidades de Saúde da Família, as unidades rurais e a Casa dos Idosos também demandam profissionais, apoio administrativo, registros assistenciais, controle de materiais, higienização, conservação dos ambientes e integração com os demais serviços da rede.

A eventual interrupção ou redução das atividades poderá provocar aumento do tempo de espera, descontinuidade de tratamentos, perda do acompanhamento longitudinal, sobrecarga das equipes, falhas nos registros, dificuldades de acesso e maior risco assistencial aos usuários.

Nesse contexto, o Projeto FORSAÚDE permitirá fortalecer temporariamente a capacidade técnica, assistencial, administrativa, operacional e logística da Secretaria Municipal de Saúde, mediante execução complementar vinculada às demandas formalmente apresentadas, às metas, aos indicadores, aos cronogramas e aos resultados estabelecidos neste Plano de Trabalho.

A proposta também se justifica pela necessidade de aprimorar o planejamento e o acompanhamento das atividades executadas. A adoção de instrumentos padronizados de solicitação, escalas, controles, registros assistenciais, relatórios mensais e indicadores permitirá maior rastreabilidade dos serviços, identificação das unidades atendidas, acompanhamento da produção e avaliação dos resultados alcançados.

A execução deverá contribuir para a organização das escalas e dos fluxos assistenciais, para a cobertura das atividades necessárias ao funcionamento das unidades, para o adequado registro da produção e para a melhoria da comunicação entre a Secretaria, os estabelecimentos de saúde e os profissionais envolvidos.

As ações serão desenvolvidas em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, especialmente universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização, humanização e participação social.

A execução também deverá observar os protocolos assistenciais, as normas sanitárias, as medidas de biossegurança, a segurança do paciente, a prevenção e o controle de infecções, o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde e a proteção dos dados pessoais e das informações clínicas dos usuários.

A atuação da OSCIP terá natureza complementar, transitória e orientada por resultados, sem transferência da gestão municipal do SUS, da regulação assistencial, da autoridade sanitária, da definição das políticas públicas, do poder de fiscalização ou das decisões administrativas reservadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Caberá ao Município definir as prioridades, formalizar as demandas, estabelecer os fluxos assistenciais, acompanhar a execução, fiscalizar a parceria e validar os resultados apresentados. Caberá à entidade parceira selecionar, contratar, coordenar e supervisionar os profissionais necessários, mantendo os controles e documentos relacionados à execução.

Dessa forma, o Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal apresenta-se como medida necessária e de relevante interesse público para preservar a continuidade dos serviços, fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal de Saúde, apoiar o funcionamento dos 11 estabelecimentos cadastrados no CNES e proporcionar atendimento mais organizado, humanizado, seguro e resolutivo à população de Dom Aquino/MT.

4. OBJETIVOS E METAS

4.1. Objetivo Geral

Fortalecer a capacidade técnica, assistencial, administrativa, operacional e logística da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Aquino/MT, mediante a execução complementar de atividades voltadas à continuidade e à qualificação dos serviços regulares da rede municipal de saúde, ao apoio ao funcionamento das unidades municipais de saúde, à organização dos fluxos assistenciais, das escalas e dos processos

de trabalho, ao registro e monitoramento das atividades executadas e à melhoria do acesso, do acolhimento, da segurança e da resolutividade do atendimento prestado à população durante o período de execução do Termo de Parceria.

4.2. Objetivos Específicos

- Apoiar a continuidade das atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde;
- Fortalecer o funcionamento regular dos estabelecimentos municipais de saúde;
- Ampliar a capacidade de atendimento das demandas formalmente apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde e consideradas compatíveis com o objeto do projeto;
- Apoiar a organização das escalas, agendas, fluxos assistenciais e processos de trabalho necessários ao funcionamento das unidades e serviços municipais de saúde;
- Contribuir para a continuidade dos atendimentos médicos, de enfermagem, técnicos, multiprofissionais, administrativos e operacionais ofertados à população;
- Fortalecer as ações desenvolvidas no âmbito da Atenção Primária à Saúde, observando a territorialização, o acolhimento, o vínculo, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado;
- Apoiar o funcionamento das unidades de saúde localizadas nas áreas urbana e rural, considerando as necessidades específicas de cada território;
- Contribuir para a manutenção das atividades assistenciais e operacionais das unidades de saúde pública do município, conforme sua capacidade instalada e os serviços formalmente definidos pela Secretaria;
- Fortalecer as rotinas de organização, conferência, atualização, arquivamento e proteção dos prontuários e demais documentos assistenciais e administrativos;
- Apoiar a alimentação, a atualização e a conferência dos sistemas de informação utilizados pela rede municipal de saúde;
- Contribuir para o registro adequado da produção assistencial, dos procedimentos realizados, dos atendimentos executados e das demais atividades desenvolvidas;
- Apoiar as atividades de enfermagem, assistência multiprofissional, reabilitação, assistência farmacêutica e demais ações compatíveis com as atribuições profissionais previstas;

- Contribuir para a organização, o controle, o armazenamento, a distribuição e o acompanhamento dos medicamentos, materiais, insumos e equipamentos utilizados nos serviços municipais de saúde;
- Apoiar as atividades de transporte sanitário, deslocamento de usuários, equipes, materiais, documentos e equipamentos, conforme programação da Secretaria;
- Fortalecer as rotinas de limpeza, higienização, conservação e organização dos ambientes das unidades de saúde;
- Contribuir para a adoção das medidas de biossegurança, prevenção e controle de infecções, gerenciamento de resíduos e segurança do paciente;
- Apoiar a organização e o acompanhamento dos plantões, das escalas profissionais, das substituições e das demais necessidades relacionadas à continuidade assistencial;
- Reduzir riscos de descontinuidade dos atendimentos decorrentes de insuficiência temporária de estrutura técnica, assistencial, administrativa ou operacional;
- Assegurar que os profissionais mobilizados possuam formação, habilitação e registro profissional compatíveis com as atividades desempenhadas;
- Garantir que os atos privativos de cada categoria profissional sejam executados exclusivamente por profissionais legalmente habilitados;
- Assegurar que as atividades sejam realizadas em conformidade com os protocolos assistenciais, as normas sanitárias, os princípios éticos e as diretrizes do Sistema Único de Saúde;
- Contribuir para a humanização do atendimento, o acolhimento qualificado, o respeito à dignidade e a proteção dos direitos dos usuários;
- Aprimorar os mecanismos de planejamento, formalização, registro, controle e monitoramento das atividades executadas;
- Implementar o registro e o acompanhamento de 100% das atividades realizadas no âmbito do projeto;
- Elaborar relatórios periódicos contendo informações quantitativas e qualitativas sobre as atividades, unidades apoiadas, profissionais mobilizados, atendimentos realizados, intercorrências e resultados alcançados;
- Acompanhar mensalmente os indicadores e os resultados, permitindo a identificação de pendências, riscos, falhas, impedimentos e necessidades de reprogramação;
- Apoiar a adoção de medidas corretivas destinadas à melhoria dos processos de trabalho, da qualidade assistencial e da continuidade dos serviços;
- Realizar as capacitações programadas para os profissionais e prestadores envolvidos na execução do projeto;

- Promover a atualização e a padronização dos procedimentos relacionados à segurança do paciente, biossegurança, acolhimento, registros assistenciais, proteção de dados e demais temas pertinentes;
- Assegurar a confidencialidade, a integridade e o uso adequado dos dados pessoais e das informações de saúde dos usuários;
- Produzir informações que subsidiem o monitoramento, a fiscalização, a avaliação, a prestação de contas e a tomada de decisão pelos agentes públicos municipais competentes;
- Contribuir para a utilização eficiente, transparente e vinculada dos recursos destinados à execução do projeto;
- Fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando melhores condições para a continuidade, a organização, a segurança e a resolutividade dos serviços prestados à população de Dom Aquino/MT.

4.3. Metas Do Projeto

As metas do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal foram definidas de forma objetiva, mensurável e compatível com a natureza técnica, assistencial, administrativa, operacional e logística das atividades a serem desenvolvidas durante o período de 180 dias consecutivos e ininterruptos.

A execução será acompanhada por meio de solicitações formais, escalas, registros assistenciais, controles administrativos e operacionais, relatórios mensais, indicadores de produção, listas de presença, registros de capacitação e demais evidências compatíveis com os serviços executados.

- **Meta 1** – Executar índice acima de 90% das demandas técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas formalmente solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde;
- **Meta 2** – Implementar o registro e o acompanhamento de 100% das atividades executadas, com monitoramento mensal dos resultados alcançados;
- **Meta 3** – Executar 100% das capacitações programadas para o período de 180 dias.

Meta	Descrição da Meta	Indicador	Forma de Aferição
01	Executar índice acima de 90% das demandas técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas formalmente solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde	Percentual de demandas executadas em relação às demandas formalmente solicitadas no período.	$(\text{Demandas executadas} \div \text{demandas formalmente solicitadas}) \times 100$
02	Implementar o registro e o acompanhamento de 100% das atividades executadas, com monitoramento periódico dos resultados alcançados	Percentual de atividades registradas e monitoradas em relação ao total de atividades executadas.	$(\text{Atividades registradas e monitoradas} \div \text{atividades executadas}) \times 100$
03	Executar 100% das capacitações programadas para o período de 180 dias	Percentual de capacitações realizadas em relação às capacitações programadas para a vigência do projeto	$(\text{Capacitações realizadas} \div \text{capacitações programadas}) \times 100$

5. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO

A metodologia do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal será orientada pela execução planejada, complementar, integrada e monitorada das atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas necessárias ao fortalecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Aquino/MT.

A execução será organizada a partir das demandas formalmente apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, observando-se a competência municipal para definição das prioridades sanitárias, das unidades a serem atendidas, dos serviços necessários, das escalas, dos fluxos assistenciais e dos resultados esperados. Cada demanda deverá ser analisada quanto à compatibilidade com o objeto do projeto, à viabilidade de execução e à disponibilidade dos profissionais habilitados, materiais, medicamentos, insumos, equipamentos, ambientes, sistemas e demais condições necessárias.

As atividades serão desenvolvidas mediante planejamento integrado, organização das escalas e agendas, mobilização dos profissionais e prestadores, definição das unidades e serviços a serem apoiados, execução das ações, registro da

produção, acompanhamento dos resultados e adoção de medidas corretivas quando necessárias.

A estratégia de atuação será estruturada em três eixos: execução das demandas técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas formalmente solicitadas e aptas ao atendimento; registro, acompanhamento e monitoramento de todas as atividades efetivamente executadas; e realização das capacitações programadas para os profissionais e prestadores envolvidos no projeto.

A metodologia deverá assegurar a correspondência entre as demandas solicitadas, as escalas e atividades programadas, os profissionais e recursos mobilizados, os serviços executados, a produção registrada e os resultados comprovados, permitindo o adequado acompanhamento físico e financeiro da parceria.

A atuação da OSCIP será complementar e orientada por resultados, permanecendo sob sua responsabilidade a seleção, contratação, coordenação, supervisão, substituição e gestão dos profissionais e prestadores necessários à execução das ações. Não haverá subordinação direta dos profissionais aos agentes públicos municipais, cessão de pessoal ou substituição das competências próprias da Administração Pública.

5.1. Meta 1 – Executar Índice Acima De 90% Das Demandas Técnicas, Assistenciais, Administrativas, Operacionais E Logísticas Formalmente Solicitadas Pela Secretaria Municipal De Saúde

A execução da Meta 1 ocorrerá por meio de fluxo estruturado de planejamento, recebimento, formalização, análise, programação, execução, acompanhamento, conclusão e validação das demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para fins de apuração, serão consideradas somente as demandas compatíveis com o objeto do projeto, formalmente solicitadas e acompanhadas das informações, autorizações, escalas, profissionais habilitados, unidades, ambientes, medicamentos, materiais, insumos, equipamentos, sistemas e demais condições necessárias à execução.

- Planejamento Integrado das Atividades

No início da execução, será realizado alinhamento entre a Secretaria Municipal de Saúde e a entidade parceira para identificação das prioridades, das unidades e serviços a serem apoiados, das escalas existentes, das necessidades assistenciais, das

demandas administrativas e operacionais, dos fluxos de atendimento e das ações programadas para o período.

O planejamento deverá estabelecer os fluxos de comunicação, os responsáveis pela interlocução, os instrumentos utilizados para formalização das solicitações, os critérios de priorização, os prazos referenciais e os mecanismos de registro, acompanhamento, validação e comprovação das atividades executadas.

Também deverão ser considerados os horários de funcionamento das unidades, as escalas profissionais, a capacidade instalada dos estabelecimentos, o perfil da população atendida, as demandas das áreas urbana e rural, os fluxos de referência e contrarreferência, a disponibilidade de profissionais, materiais, medicamentos, insumos e equipamentos e as condições sanitárias, técnicas e de segurança necessárias à execução.

O planejamento poderá ser atualizado durante a vigência conforme as necessidades formalmente identificadas, desde que sejam preservados o objeto, as metas, os limites de atuação e os resultados estabelecidos neste Plano de Trabalho.

- Recebimento e Formalização das Demandas

As demandas deverão ser encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde por meio físico ou eletrônico previamente definido entre as partes.

O registro deverá conter, conforme aplicável, a descrição da atividade solicitada, a unidade ou serviço relacionado, o período de execução, a escala ou carga horária necessária, a categoria profissional, o quantitativo estimado, os materiais, medicamentos, insumos e equipamentos envolvidos, o responsável pela solicitação e o resultado esperado.

As solicitações verbais deverão ser convertidas em registro formal para fins de organização, programação, acompanhamento, comprovação e apuração da meta.

As demandas incompletas ou que dependam de autorização, escala, profissional habilitado, condições estruturais, materiais, medicamentos, insumos, equipamentos, sistemas ou outras condições permanecerão registradas como pendentes até sua regularização.

- **Triagem, Análise e Classificação**

Após o recebimento, cada demanda será analisada quanto à compatibilidade com o projeto, à natureza da atividade, à unidade ou serviço relacionado, ao prazo, à disponibilidade dos profissionais e recursos e às condições necessárias ao atendimento.

As demandas poderão ser classificadas como técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais ou logísticas. Também poderão ser classificadas como rotineiras, programadas, prioritárias, urgentes ou pendentes.

A priorização deverá considerar a continuidade dos serviços, os riscos assistenciais, a necessidade de cobertura de escalas e plantões, a vulnerabilidade dos usuários, a possibilidade de agravamento das condições de saúde, o impacto sobre o funcionamento das unidades e as orientações formalmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

As solicitações que envolvam regulação assistencial, definição de política pública, exercício de autoridade sanitária, emissão de parecer institucional, autorização administrativa, fiscalização, aplicação de sanções ou tomada de decisão reservada ao Município deverão ser encaminhadas aos agentes públicos competentes.

- **Execução das Demandas e Tratamento das Pendências e Impedimentos**

As atividades serão executadas conforme a programação aprovada, os limites do objeto, as atribuições referenciais dos profissionais mobilizados, os protocolos assistenciais e as normas técnicas, sanitárias, éticas e de segurança aplicáveis.

A execução poderá compreender atendimentos médicos, de enfermagem, técnicos e multiprofissionais; cobertura de escalas e plantões; apoio às unidades urbanas e rurais; atividades de reabilitação; assistência farmacêutica; recepção, acolhimento e orientação aos usuários; organização de agendas e prontuários; alimentação dos sistemas de informação; transporte sanitário; limpeza, higienização e conservação das unidades; controle de materiais e insumos; e demais atividades compatíveis com o projeto.

Os profissionais deverão atuar de acordo com sua formação, habilitação, registro no respectivo conselho de classe e competência técnica, observando os princípios éticos, os protocolos assistenciais e os limites regulamentares de cada categoria.

As atividades deverão observar as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, o perfil dos usuários, as condições das unidades, os fluxos assistenciais, as normas de

biossegurança, a segurança do paciente, o sigilo profissional, a proteção dos dados pessoais e os procedimentos de prevenção e controle de infecções.

Quando uma demanda não puder ser iniciada, continuada ou concluída, a ocorrência deverá ser formalmente registrada, indicando-se o motivo, as providências adotadas e a possibilidade de reprogramação.

Poderão constituir impedimentos a ausência de autorização, escala, profissional habilitado, materiais, medicamentos, insumos ou equipamentos; inadequação das condições sanitárias ou estruturais; indisponibilidade da unidade; risco à segurança do usuário ou do profissional; alteração da programação municipal; cancelamento institucional; ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Sempre que o impedimento possuir caráter temporário, a atividade deverá ser reprogramada dentro do período de vigência, observadas as condições necessárias à execução.

- Acompanhamento, Conclusão, Validação e Apuração do Cumprimento da Meta

O acompanhamento das demandas deverá ocorrer continuamente, desde seu recebimento e formalização até a conclusão da atividade, permitindo verificar a situação de cada solicitação, os prazos, as escalas, os responsáveis, as providências adotadas, as pendências e os resultados alcançados.

Após a realização, a demanda deverá ser registrada como concluída e acompanhada das evidências compatíveis com sua natureza, tais como escalas, registros assistenciais, controles de produção, formulários, relatórios, sistemas de informação, registros administrativos e demais elementos que permitam comprovar a execução.

A validação deverá ser realizada pelo responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante análise dos registros, relatórios e evidências apresentados, sem prejuízo das atribuições da fiscalização da parceria.

Ao final de cada mês, as informações serão consolidadas para apuração do percentual de cumprimento da meta, mediante aplicação da seguinte fórmula:

Percentual de execução = (número de demandas executadas ÷ número de demandas formalmente solicitadas e aptas à execução) × 100.

A Meta 1 será considerada cumprida quando o índice apurado for superior a 90%.

As demandas não executadas por fatores externos à atuação da OSCIP deverão permanecer registradas e acompanhadas das respectivas justificativas e evidências.

Ao término dos 180 dias, será realizada consolidação final contendo o total de demandas recebidas, executadas, pendentes, reprogramadas, impedidas ou canceladas, o percentual alcançado e a avaliação qualitativa dos resultados produzidos.

5.2. Meta 2 – Implementar o Registro e o Acompanhamento de 100% das Atividades Executadas, com Monitoramento Mensal dos Resultados Alcançados;

A execução desta meta será conduzida por meio da implantação de metodologia estruturada de registro, acompanhamento, consolidação e monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal, assegurando a rastreabilidade das ações realizadas durante os 180 dias de vigência.

O processo de monitoramento terá como finalidade reunir, organizar e analisar as informações relacionadas às atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas executadas, especialmente aquelas vinculadas aos atendimentos, plantões, escalas, atividades de enfermagem, ações multiprofissionais, reabilitação, assistência farmacêutica, recepção, apoio à regulação, transporte sanitário, limpeza, higienização, conservação e demais serviços regulares da rede municipal.

Todas as atividades executadas deverão ser registradas em instrumento físico ou eletrônico compatível com sua natureza. Os registros deverão permitir a identificação da unidade, da data, da atividade realizada, do profissional responsável, da escala ou demanda relacionada, dos atendimentos ou procedimentos executados, das intercorrências, dos encaminhamentos e dos resultados alcançados.

O cumprimento da meta será aferido pela relação entre o total de atividades executadas, registradas e monitoradas e o total de atividades efetivamente realizadas durante o período.

- **Definição dos Instrumentos de Registro e Acompanhamento**

No início da execução, serão definidos e padronizados os instrumentos físicos ou eletrônicos destinados ao registro, ao controle e ao acompanhamento das atividades.

Poderão ser utilizados formulários assistenciais, escalas, folhas de frequência, agendas, planilhas, relatórios, controles de produção, sistemas de informação, registros de ocorrência, listas de verificação e demais documentos compatíveis.

A definição dos instrumentos deverá observar as normas de sigilo profissional, proteção de dados pessoais, segurança da informação e acesso restrito às informações de saúde.

- Registro Sistemático das Atividades Executadas

Todas as atividades efetivamente realizadas deverão ser registradas continuamente, preferencialmente no momento da execução ou imediatamente após sua conclusão.

Os registros deverão demonstrar os atendimentos e procedimentos realizados, as escalas cumpridas, as atividades administrativas e operacionais desenvolvidas, os usuários orientados, os materiais e insumos utilizados, os deslocamentos efetuados, as ações de limpeza e higienização realizadas e as demais providências adotadas.

As atividades realizadas sem documentação suficiente deverão ser objeto de complementação antes do fechamento do relatório mensal correspondente, respeitando-se o sigilo profissional, a proteção dos dados pessoais e as normas de segurança da informação.

Os relatórios de monitoramento não deverão expor informações clínicas individualizadas ou dados pessoais desnecessários à comprovação da execução.

- Consolidação e Análise dos Dados

Ao final de cada mês, os registros serão consolidados para demonstrar as demandas recebidas, as atividades executadas, as unidades apoiadas, as escalas cumpridas, os profissionais mobilizados, os atendimentos e procedimentos realizados, as pendências, as reprogramações, as intercorrências e os resultados alcançados.

O monitoramento deverá permitir a comparação entre as atividades programadas e executadas, a verificação das escalas e dos prazos, a análise da produção, a identificação de falhas ou riscos assistenciais e a necessidade de ajustes nos processos de trabalho.

A consolidação deverá preservar a confiabilidade das informações e permitir a correspondência entre as demandas formalizadas, os profissionais mobilizados, as atividades realizadas e os registros apresentados.

- Elaboração de Relatórios Periódicos de Monitoramento

Com base nas informações consolidadas, serão elaborados relatórios mensais de execução física.

Os relatórios deverão apresentar, no mínimo, as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas realizadas, as unidades apoiadas, os profissionais mobilizados, as escalas cumpridas, os atendimentos e procedimentos executados, as atividades de recepção, reabilitação, assistência farmacêutica, transporte, limpeza e apoio operacional, as pendências, as intercorrências e os resultados alcançados.

As informações deverão ser acompanhadas das evidências compatíveis com a natureza de cada atividade, preservando-se os dados pessoais, o sigilo profissional e a confidencialidade das informações clínicas.

Os relatórios deverão apresentar informações quantitativas e qualitativas suficientes para subsidiar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação do projeto.

- Acompanhamento dos Resultados e Apuração do Cumprimento da Meta

A validação das atividades deverá ser realizada pelo responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante análise dos relatórios, controles e evidências apresentados.

A apuração será realizada por meio da seguinte fórmula:

Percentual de atividades registradas e monitoradas = (número de atividades executadas, registradas e monitoradas ÷ número total de atividades executadas) × 100.

A Meta 2 será considerada cumprida quando 100% das atividades executadas estiverem devidamente registradas, acompanhadas e contempladas nos relatórios mensais.

As inconsistências, lacunas ou ausência de registros deverão ser comunicadas aos responsáveis para complementação e adoção das medidas corretivas necessárias.

Ao término dos 180 dias, será realizada consolidação final contendo o total de atividades executadas, registradas e monitoradas, o percentual alcançado, as principais pendências, as intercorrências identificadas e a avaliação dos resultados produzidos.

5.3. Meta 3 – Executar 100% das capacitações programadas para o período de 180 dias

A execução desta meta será direcionada à realização integral das capacitações programadas no âmbito do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal, com a finalidade de aprimorar conhecimentos, padronizar procedimentos e fortalecer a qualidade, a humanização e a segurança das atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas.

As capacitações deverão estar diretamente relacionadas às necessidades identificadas durante a execução, às atribuições dos profissionais mobilizados e às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

- **Identificação das Necessidades de Capacitação**

No início da vigência, será realizado levantamento das necessidades de capacitação, considerando os serviços previstos, os riscos assistenciais e ocupacionais, os fluxos de atendimento, as dificuldades identificadas, os sistemas utilizados e os procedimentos que necessitem de orientação ou padronização.

O levantamento poderá contemplar acolhimento e humanização, segurança do paciente, biossegurança, prevenção e controle de infecções, higienização dos ambientes, gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, registros assistenciais, proteção de dados pessoais, sigilo profissional, utilização dos sistemas de informação, administração segura de medicamentos, comunicação entre equipes, transporte sanitário e demais conteúdos compatíveis com o projeto.

As necessidades poderão ser atualizadas durante a vigência, conforme as ocorrências, dificuldades, riscos e oportunidades de melhoria identificados durante o acompanhamento das atividades.

- **Planejamento das Ações de Capacitação**

Com base nas necessidades identificadas, será elaborado cronograma contendo os temas, objetivos, datas, horários, cargas horárias, públicos participantes, responsáveis pela condução, metodologia e recursos necessários.

A programação deverá ser compatível com as escalas e os horários de funcionamento das unidades, de modo a não comprometer a continuidade dos serviços assistenciais e operacionais.

Os conteúdos deverão ser adequados às atribuições e responsabilidades dos profissionais participantes, respeitando-se os limites técnicos e regulamentares de cada categoria.

Eventuais alterações deverão ser formalmente registradas, justificadas e reprogramadas dentro do período de vigência.

- Execução das Capacitações Programadas

As capacitações serão realizadas conforme o cronograma aprovado, podendo adotar metodologia presencial, expositiva, prática, demonstrativa, orientativa, participativa ou remota, conforme a natureza do conteúdo.

As atividades poderão compreender exposição de conteúdos, esclarecimento de dúvidas, demonstração de procedimentos, análise de situações, simulações, orientação prática e apresentação de medidas destinadas à melhoria da execução e à redução dos riscos.

A participação deverá ser registrada, permitindo identificar os profissionais presentes, as unidades ou serviços relacionados, os conteúdos desenvolvidos e a carga horária cumprida.

As capacitações deverão ser conduzidas por profissionais que possuam conhecimento, formação ou experiência compatíveis com os temas abordados.

- Registro e Comprovação das Ações Realizadas

Cada capacitação deverá possuir registro contendo, no mínimo, o tema, o objetivo, a data, o local ou ambiente virtual, a carga horária, o responsável pela condução, o conteúdo desenvolvido e os participantes.

A comprovação poderá ocorrer por meio de listas de presença, relatórios, atas, materiais de apoio, registros fotográficos, certificados, declarações de participação, avaliações e demais evidências compatíveis.

Os documentos deverão ser organizados por atividade e período, de forma a permitir o acompanhamento da programação e a comprovação do cumprimento da meta.

- Avaliação dos Resultados e Apuração do Cumprimento da Meta

O acompanhamento será realizado durante toda a vigência, mediante comparação entre as capacitações programadas e aquelas efetivamente executadas.

A avaliação poderá considerar a participação dos profissionais, a compreensão dos conteúdos, a aplicabilidade das orientações, a melhoria dos procedimentos e a redução de falhas ou riscos relacionados às atividades desenvolvidas.

A validação caberá ao responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante análise dos registros e das evidências apresentadas.

A apuração será realizada conforme a seguinte fórmula:

Percentual de capacitações executadas = (número de capacitações realizadas ÷ número de capacitações programadas) × 100.

A Meta 3 será considerada cumprida quando forem realizadas 100% das capacitações programadas para o período de 180 dias.

As capacitações não realizadas na data inicialmente prevista deverão ser justificadas e reprogramadas dentro da vigência, assegurando-se a execução integral da programação aprovada.

Ao término da vigência, será elaborada consolidação final contendo o total de capacitações programadas, realizadas, reprogramadas ou pendentes, os temas desenvolvidos, o público participante, o percentual alcançado e a avaliação dos resultados produzidos.

6. CRONOGRAMA MENSAL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES POR META

A execução do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal ocorrerá durante o período de 180 dias consecutivos e ininterruptos, correspondente a seis meses de execução.

As atividades serão desenvolvidas de forma contínua, conforme as demandas formalmente apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, as necessidades das unidades, a disponibilidade de profissionais habilitados, as escalas, os materiais, medicamentos, insumos, equipamentos e demais condições necessárias ao funcionamento da rede municipal.

6.1. Meta 1 – Executar índice acima de 90% das demandas técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas formalmente solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde

Atividades	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Realizar o planejamento integrado das atividades	X	X	X	X	X	X
Receber e formalizar as demandas administrativas, técnicas e operacionais	X	X	X	X	X	X
Realizar a triagem, a análise e a classificação das demandas	X	X	X	X	X	X
Executar as demandas e tratar as pendências e os impedimentos identificados	X	X	X	X	X	X
Acompanhar os prazos e o andamento, concluir e validar as demandas, comprovar a execução e apurar o cumprimento da meta	X	X	X	X	X	X

Observações sobre a execução

O planejamento será iniciado no primeiro mês e atualizado durante toda a vigência, conforme as prioridades da Secretaria Municipal de Saúde, as necessidades dos estabelecimentos municipais, as escalas profissionais, os fluxos assistenciais, a capacidade das unidades e a disponibilidade de materiais, medicamentos, insumos e equipamentos.

O recebimento, a formalização, a análise, a classificação e a programação das demandas ocorrerão continuamente durante os seis meses, considerando as atividades compatíveis com o objeto do projeto, as atribuições referenciais dos profissionais e as condições técnicas, sanitárias, assistenciais, administrativas e operacionais necessárias à execução.

As demandas não executadas deverão ser registradas e justificadas. Quando o impedimento possuir caráter temporário, as atividades deverão ser reprogramadas dentro do período de vigência, sempre que possível.

A apuração será realizada mensalmente, sendo a Meta 1 considerada cumprida quando o percentual de demandas executadas for superior a 90%.

6.2. Meta 2 – Implementar o registro e o acompanhamento de 100% das atividades executadas, com monitoramento mensal dos resultados alcançados.

Atividades	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Definir os instrumentos de registro e acompanhamento das atividades executadas	X					
Registrar sistematicamente as atividades executadas	X	X	X	X	X	X
Consolidar e analisar mensalmente as informações registradas	X	X	X	X	X	X
Elaborar os relatórios mensais de monitoramento	X	X	X	X	X	X
Acompanhar os resultados e apurar o cumprimento da meta	X	X	X	X	X	X

Observações sobre a execução

Os instrumentos de registro e acompanhamento serão definidos no primeiro mês e poderão compreender prontuários, formulários assistenciais, escalas, folhas de frequência, agendas, planilhas, relatórios, controles de produção, sistemas de informação, registros de ocorrência, listas de verificação e demais documentos compatíveis.

O registro das atividades será realizado continuamente, preferencialmente no momento da execução ou imediatamente após sua conclusão, observando-se o sigilo profissional, a proteção dos dados pessoais e a confidencialidade das informações de saúde.

Ao final de cada mês, as informações serão consolidadas e apresentadas em relatório, demonstrando as unidades apoiadas, as atividades realizadas, os profissionais

mobilizados, as escalas cumpridas, os atendimentos e procedimentos executados, as pendências, as intercorrências e os resultados alcançados.

A Meta 2 será considerada cumprida quando 100% das atividades executadas estiverem devidamente registradas, acompanhadas e contempladas nos relatórios mensais.

6.3. Meta 3 – Executar 100% das capacitações programadas para o período de 180 dias

Atividades	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Identificar as necessidades de capacitação dos profissionais e prestadores envolvidos no projeto	X	X	X	X	X	X
Planejar as ações de capacitação para o período de 180 dias	X	X	X	X	X	X
Executar as capacitações programadas conforme o cronograma aprovado		X	X	X	X	X
Registrar e comprovar as ações de capacitação realizadas			X	X	X	X
Avaliar os resultados das capacitações e apurar o cumprimento da meta			X	X	X	X

Observações sobre a execução

O levantamento das necessidades de capacitação será iniciado no primeiro mês e poderá ser atualizado durante a execução, conforme os riscos assistenciais e ocupacionais, as dificuldades identificadas, os procedimentos adotados e as necessidades de orientação ou padronização dos processos de trabalho.

As capacitações serão distribuídas durante os seis meses, de forma compatível com as escalas e os horários de funcionamento das unidades, sem comprometer a continuidade dos serviços assistenciais, administrativos e operacionais.

Os conteúdos poderão abranger acolhimento e humanização, segurança do paciente, biossegurança, prevenção e controle de infecções, higienização dos ambientes, gerenciamento de resíduos, registros assistenciais, proteção de dados, sigilo profissional, utilização dos sistemas de informação, administração segura de medicamentos, transporte sanitário e comunicação entre as equipes.

Cada capacitação deverá ser registrada por meio de lista de presença, relatório, conteúdo programático, carga horária, identificação do responsável, materiais utilizados, registros fotográficos e demais evidências compatíveis.

As capacitações não realizadas na data prevista deverão ser justificadas e reprogramadas dentro da vigência, assegurando-se a execução integral da programação.

A Meta 3 será considerada cumprida quando forem realizadas 100% das capacitações programadas para o período de 180 dias.

7. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO

A formação dos custos do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal compreenderá as despesas necessárias à execução das atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas previstas neste Plano de Trabalho durante o período de 180 dias consecutivos e ininterruptos.

A composição financeira deverá manter correspondência direta com as metas estabelecidas, as atividades programadas, os quantitativos referenciais, as formas de contratação, os serviços efetivamente executados e os resultados esperados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Os custos serão organizados em dois grupos: execução direta do projeto e despesas administrativas e operacionais, permitindo identificar os valores destinados às atividades finalísticas da rede municipal de saúde e aqueles necessários à gestão, coordenação, supervisão, monitoramento, controle financeiro e prestação de contas da parceria.

7.1. Execução Direta do Projeto

A execução direta compreenderá os custos relacionados aos profissionais, prestadores, serviços e atividades necessários ao funcionamento regular da rede municipal de saúde, incluindo atendimentos médicos, de enfermagem, técnicos e

multiprofissionais, cobertura de escalas e plantões, apoio às unidades urbanas e rurais, reabilitação, assistência farmacêutica, recepção, apoio administrativo, transporte sanitário, limpeza, higienização, conservação e demais atividades compatíveis com o objeto do projeto.

O quadro de atividades do projeto é apresentado no **ANEXO I** deste plano de trabalho, onde os valores unitários adotados consideram a média de mercado praticada no município e região, estando compatíveis com a complexidade das atividades, a carga horária exigida e as especificidades técnicas de cada especialidade.

Os quantitativos possuem natureza referencial e estimativa, destinando-se ao dimensionamento da estrutura necessária ao cumprimento das metas. A execução efetiva ficará condicionada às demandas formalmente solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, à disponibilidade financeira, à compatibilidade com o objeto, à necessidade das unidades e à comprovação das atividades realizadas.

Nos casos de contratação de pessoa jurídica, o pagamento deverá estar vinculado à efetiva execução do serviço, à apresentação do documento fiscal correspondente, ao relatório das atividades e às demais comprovações exigidas.

Nos casos de contratação sob vínculo celetista, a formação do custo deverá contemplar os proventos, os encargos, as provisões e as demais obrigações trabalhistas incidentes, conforme demonstrativo financeiro específico.

As atividades assistenciais somente poderão ser executadas por profissionais que possuam formação, habilitação e registro regular no respectivo conselho de classe, quando exigidos, permanecendo a remuneração condicionada à comprovação da regularidade profissional, da escala, da produção e da efetiva prestação dos serviços.

7.2. Despesas Administrativas e Operacionais

As despesas administrativas e operacionais compreendem os custos indiretos indispensáveis à adequada execução, coordenação, supervisão, gestão de pessoas, monitoramento, controle financeiro, faturamento, prestação de contas do Plano de Trabalho, dentre outras, durante os 180 dias de execução.

Poderão integrar essa categoria as despesas relacionadas à administração da parceria, assessoria contábil, apoio jurídico-administrativo, tecnologia da informação, serviços bancários, comunicação, materiais de expediente, locações, deslocamentos, gestão documental, conferência de escalas e produção, elaboração de relatórios, processamento financeiro e demais custos necessários à execução.

Essas despesas não se confundem com os custos da execução direta apresentados no item 7.1, uma vez que se destinam à manutenção da estrutura necessária ao gerenciamento da parceria, à organização documental e financeira, ao acompanhamento das metas e à demonstração da regular aplicação dos recursos públicos.

A estrutura administrativa e operacional assegurará condições para o planejamento das ações, a coordenação dos serviços, a organização dos documentos, o controle dos recursos, a elaboração dos relatórios, o acompanhamento dos indicadores e o atendimento das exigências relacionadas à fiscalização e à prestação de contas.

O quadro da composição de custos por categoria de despesas é apresentado no **ANEXO II** deste plano de trabalho, onde os valores totais e rateados por secretaria vinculada ao Termo de Parceria, considerando a média de mercado praticada no município e região.

Essas despesas, previstas no Plano de Aplicação dos Recursos, serão devidamente comprovadas por documentos fiscais, comprovantes de pagamento, contratos, relatórios e demais evidências pertinentes.

7.3. Custo Total do Projeto

O custo total do Projeto contempla a soma dos custos diretos (Execução Direta do Projeto) e indiretos (Despesas Administrativas e Operacionais) necessários à plena execução das atividades, conforme Plano de Trabalho e cronogramas estabelecidos, respeitando os limites, critérios e diretrizes definidos no Termo de Parceria.

Período de Execução	Execução Direta do Projeto	Despesas Administrativas e Operacionais	Custo Total do Projeto
Mensal	R\$ 440.013,38	R\$ 42.901,31	R\$ 482.914,69
Semestral	R\$ 2.640.080,28	R\$ 257.407,86	R\$ 2.897.488,14

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O desembolso dos recursos financeiros ocorrerá de forma mensal, conforme cronograma pactuado no Termo de Parceria, observando o volume de atividades executadas e os custos previstos.

Meses	Custo Previsto		Custo Total Mensal
	Execução Direta do Projeto	Despesas Administrativas e Operacionais	
1	R\$ 440.013,38	R\$ 42.901,31	R\$ 482.914,69
2	R\$ 440.013,38	R\$ 42.901,31	R\$ 482.914,69
3	R\$ 440.013,38	R\$ 42.901,31	R\$ 482.914,69
4	R\$ 440.013,38	R\$ 42.901,31	R\$ 482.914,69
5	R\$ 440.013,38	R\$ 42.901,31	R\$ 482.914,69
6	R\$ 440.013,38	R\$ 42.901,31	R\$ 482.914,69
Custo Total 06 Meses	R\$ 2.640.080,28	R\$ 257.407,86	R\$ 2.897.488,14

9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Com a execução do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal, espera-se assegurar a continuidade das atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde durante o período de 180 dias.

Espera-se aprimorar o planejamento, a formalização, a análise, a priorização e a programação das atividades da rede municipal, permitindo maior organização das demandas, melhor distribuição dos profissionais e recursos disponíveis e maior agilidade na execução dos serviços.

A execução do projeto deverá fortalecer o funcionamento regular dos estabelecimentos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, incluindo as unidades urbanas e rurais, o Hospital Municipal, o Centro de Saúde, as unidades de Saúde da Família, o Centro de Reabilitação, a Central Municipal de Regulação, a Farmácia Básica e os demais serviços municipais cadastrados no CNES.

Também se espera ampliar o apoio às atividades médicas, de enfermagem, técnicas e multiprofissionais, à cobertura de escalas e plantões, à reabilitação, à assistência farmacêutica, à recepção, ao acolhimento, à orientação dos usuários e às demais ações compatíveis com o objeto do projeto.

O fortalecimento da Atenção Primária à Saúde deverá contribuir para a promoção da saúde, a prevenção de doenças e agravos, o acompanhamento das condições crônicas, o cuidado materno-infantil, a territorialização, o vínculo entre equipes e usuários e a coordenação do cuidado.

A organização das escalas, agendas e fluxos assistenciais deverá favorecer maior regularidade no atendimento, redução de descontinuidades, melhor distribuição das atividades entre as unidades e maior capacidade de resposta às necessidades identificadas pela gestão municipal.

A elaboração de relatórios mensais deverá ampliar a rastreabilidade das ações e proporcionar informações quantitativas e qualitativas para o monitoramento, a fiscalização, a avaliação e a prestação de contas do projeto, preservando-se o sigilo profissional e a proteção dos dados pessoais e das informações de saúde.

O acompanhamento contínuo deverá permitir a identificação tempestiva de pendências, riscos assistenciais, falhas, ausências, impedimentos e necessidades de

A integração entre as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas deverá reduzir retrabalhos, falhas de comunicação, inconsistências nos registros, atrasos na organização das escalas e interrupções evitáveis no funcionamento dos serviços.

Ao término dos 180 dias, espera-se que a Secretaria Municipal de Saúde apresente melhores condições de organização, planejamento, execução, controle e acompanhamento das demandas, com reflexos positivos na continuidade dos serviços, no funcionamento das unidades, na segurança assistencial, na humanização do atendimento e na qualidade da assistência prestada à população de Dom Aquino/MT. A estrutura desta seção segue o formato do modelo apresentado pela usuária.

9.1. Resultados Esperados

Com a execução do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- Manutenção da continuidade das atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;
- Melhoria do planejamento, da organização, da priorização e da programação das demandas e atividades da rede municipal;
- Maior agilidade no atendimento das demandas formalmente apresentadas pelas unidades e serviços de saúde;
- Fortalecimento do funcionamento regular dos estabelecimentos municipais cadastrados no CNES;
- Maior continuidade dos atendimentos ofertados nas unidades urbanas e rurais;
- Fortalecimento das atividades da Atenção Primária à Saúde e do acompanhamento territorial das famílias;
- Apoio à manutenção das escalas médicas, de enfermagem, técnicas, multiprofissionais, administrativas e operacionais;

- Maior organização dos plantões, agendas, fluxos assistenciais e processos de trabalho;
- Redução dos riscos de interrupção ou descontinuidade dos atendimentos;
- Continuidade das atividades de reabilitação e do acompanhamento multiprofissional dos usuários;
- Fortalecimento da assistência farmacêutica e dos controles relacionados aos medicamentos e insumos;
- Melhoria da organização da recepção, do acolhimento, da orientação, do agendamento e do encaminhamento dos usuários;
- Apoio à organização, atualização, arquivamento e proteção dos prontuários e documentos assistenciais;
- Melhoria da alimentação, da conferência e da atualização dos sistemas de informação utilizados pela rede municipal;
- Fortalecimento do registro da produção assistencial, dos procedimentos e das atividades realizadas;
- Apoio mais organizado às atividades de transporte sanitário e aos deslocamentos programados;
- Melhoria das condições de limpeza, higienização, conservação e organização dos ambientes das unidades;
- Fortalecimento das práticas de biossegurança, prevenção e controle de infecções e segurança do paciente;
- Maior controle dos materiais, medicamentos, insumos, equipamentos e demais recursos utilizados na execução;
- Mobilização de profissionais com formação, habilitação e registro compatíveis com as atividades desempenhadas;
- Implantação e utilização de instrumentos padronizados de solicitação, registro, controle, acompanhamento, validação e comprovação das atividades;
- Produção de relatórios mensais contendo informações quantitativas e qualitativas sobre as unidades apoiadas, os profissionais mobilizados, as escalas cumpridas, os atendimentos realizados, as intercorrências e os resultados alcançados;

- Maior rastreabilidade entre as demandas formalizadas, as atividades programadas, os profissionais mobilizados, os serviços executados e as evidências apresentadas;
- Identificação tempestiva de riscos, falhas, pendências, impedimentos e necessidades de reprogramação;
- Aprimoramento dos mecanismos de monitoramento, fiscalização, avaliação e prestação de contas;
- Fortalecimento da humanização, do acolhimento, da comunicação entre equipes, do sigilo profissional e da proteção dos dados pessoais;
- Redução de retrabalhos, inconsistências nos registros, falhas de comunicação e interrupções evitáveis;
- Fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria Municipal de Saúde;
- Maior eficiência, transparência e organização na utilização dos recursos destinados ao projeto;
- Melhoria da capacidade de resposta do Município às necessidades regulares de saúde da população;
- Melhoria da qualidade, da segurança, da continuidade e da resolutividade dos serviços prestados à população de Dom Aquino/MT.

9.2. Impactos Esperados

A execução do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal deverá produzir impactos institucionais, assistenciais, operacionais, sanitários e sociais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e na prestação dos serviços públicos à população de Dom Aquino/MT.

No aspecto institucional, espera-se o fortalecimento da capacidade de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento das demandas da Secretaria, com maior integração entre as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas. A adoção de fluxos padronizados deverá favorecer a definição de prioridades, a organização das escalas, a distribuição dos recursos e a tomada de decisão pelos agentes públicos competentes.

No aspecto assistencial, o projeto deverá contribuir para maior continuidade e regularidade dos atendimentos, reduzindo riscos de desassistência temporária, cancelamentos, interrupções de escalas e sobrecarga das equipes. A programação

integrada deverá favorecer a utilização mais eficiente dos profissionais, das unidades, dos materiais, dos medicamentos, dos insumos e dos equipamentos disponíveis.

No âmbito da Atenção Primária à Saúde, espera-se fortalecer o acolhimento, o vínculo, a territorialização, a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o acompanhamento das condições crônicas e a coordenação do cuidado. Essas ações deverão contribuir para o atendimento mais próximo das famílias e para a identificação tempestiva das necessidades de saúde da população.

Nas áreas rurais, o fortalecimento das atividades deverá favorecer a continuidade do atendimento às comunidades, reduzir barreiras territoriais de acesso e proporcionar melhores condições para o acompanhamento dos usuários que residem em localidades mais distantes da sede municipal.

No âmbito hospitalar, a organização das escalas, dos plantões e dos processos de trabalho deverá contribuir para maior continuidade dos atendimentos, redução da sobrecarga das equipes e melhoria da segurança assistencial, observadas a capacidade instalada e as competências da unidade.

A organização das atividades da Central Municipal de Regulação deverá contribuir para maior controle das solicitações, agendas e encaminhamentos, favorecendo a articulação entre os serviços municipais e regionais e a orientação adequada dos usuários.

As atividades de reabilitação deverão contribuir para a continuidade dos cuidados prestados aos usuários que apresentem limitações funcionais ou necessitem de acompanhamento multiprofissional, respeitando-se a capacidade do serviço e as atribuições das categorias envolvidas.

No campo da assistência farmacêutica, espera-se ampliar o controle dos estoques, do armazenamento, da distribuição e do acompanhamento dos medicamentos e insumos, reduzindo riscos de perdas, vencimentos, falhas de registro e desabastecimentos evitáveis.

As ações de limpeza, higienização, conservação e organização dos ambientes deverão produzir impacto direto nas condições sanitárias das unidades, contribuindo para a prevenção de infecções, a biossegurança e a proteção dos usuários, trabalhadores e acompanhantes.

A organização das rotinas de transporte sanitário deverá favorecer os deslocamentos programados, a continuidade dos atendimentos e a articulação entre unidades e serviços, observadas as condições operacionais, as agendas e as prioridades estabelecidas pela Secretaria.

A implantação de instrumentos padronizados de registro e monitoramento deverá ampliar a transparência, a rastreabilidade e a confiabilidade das informações relacionadas à execução do projeto. Os relatórios produzidos deverão subsidiar a fiscalização, a avaliação dos resultados, a prestação de contas e a adoção de medidas corretivas durante a vigência.

As capacitações programadas deverão gerar impacto direto na qualidade e na segurança das atividades, contribuindo para a humanização do atendimento, a segurança do paciente, a biossegurança, a prevenção e o controle de infecções, o gerenciamento de resíduos, a melhoria dos registros e a proteção das informações de saúde.

Como impacto administrativo, o projeto deverá fortalecer a cultura de planejamento, execução orientada por metas, registro das atividades, produção de evidências, acompanhamento de indicadores e avaliação de resultados.

Como impacto operacional, espera-se reduzir falhas de comunicação, retrabalhos, inconsistências nos registros, atrasos na organização das escalas e interrupções evitáveis no funcionamento das unidades e serviços.

Como impacto sanitário, espera-se melhorar as condições de higiene, segurança, prevenção de riscos e proteção dos usuários e profissionais, fortalecendo a adoção das normas e protocolos aplicáveis aos serviços de saúde.

Como impacto social, espera-se proporcionar à população maior regularidade no acesso, atendimento mais organizado, acolhedor, humanizado e seguro e maior confiança na rede municipal de saúde.

Espera-se, ainda, que crianças, gestantes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, usuários com condições crônicas, moradores das comunidades rurais e demais grupos que necessitam de acompanhamento contínuo sejam beneficiados pela maior regularidade e organização das atividades.

Ao final dos 180 dias, espera-se que o Município disponha de uma estrutura mais organizada de recebimento, programação, execução, registro e monitoramento das demandas, com reflexos positivos na eficiência dos serviços, na continuidade do cuidado, no funcionamento dos estabelecimentos municipais, na segurança assistencial e na qualidade da atenção prestada à população de Dom Aquino/MT.

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal deverá observar integralmente o objeto, as metas, as atividades, os indicadores, o cronograma, a formação dos custos e as demais condições estabelecidas neste Plano de Trabalho e no Termo de Parceria correspondente.

O projeto será executado durante o período de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contado a partir da data formalmente definida para o início das atividades, admitindo-se alterações somente quando devidamente justificadas, formalizadas e autorizadas pelas instâncias competentes.

As atividades desenvolvidas deverão possuir caráter complementar e transitório, destinando-se ao fortalecimento da capacidade técnica, assistencial, administrativa, operacional e logística da Secretaria Municipal de Saúde, sem transferência da gestão municipal do Sistema Único de Saúde, da autoridade sanitária, da regulação assistencial, da formulação das políticas públicas ou das competências legalmente reservadas ao Poder Público.

Caberá à Secretaria Municipal de Saúde definir as prioridades, formalizar as demandas, indicar as unidades e os serviços a serem apoiados, estabelecer os fluxos assistenciais, acompanhar a execução, validar as atividades realizadas e exercer a fiscalização da parceria.

A relação estabelecida entre o Município e a OSCIP não implicará transferência de vínculo funcional, subordinação direta dos profissionais à Administração Pública, cessão de mão de obra ou delegação de atribuições exclusivas dos servidores, agentes públicos ou autoridades sanitárias municipais.

As contratações deverão observar critérios de legalidade, impessoalidade, capacidade técnica, economicidade, compatibilidade com o objeto e regularidade documental, respeitando-se os procedimentos internos da entidade e as exigências aplicáveis à utilização de recursos públicos.

Os profissionais deverão possuir formação, experiência, habilitação e registro nos respectivos conselhos de classe, quando exigidos, e somente poderão executar atividades compatíveis com suas atribuições legais, técnicas e regulamentares.

Os atos privativos de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, técnicos, auxiliares e demais categorias profissionais deverão ser realizadas exclusivamente por pessoas legalmente habilitadas.

A responsabilidade técnica pelos serviços deverá ser exercida por profissional devidamente habilitado e formalmente indicado, quando exigida pela natureza da atividade, pelo conselho profissional competente ou pelas normas sanitárias aplicáveis.

As atividades deverão ser executadas conforme os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os protocolos assistenciais, as normas sanitárias, as regras de biossegurança, a segurança do paciente, a prevenção e o controle de infecções e os códigos de ética das categorias profissionais.

A organização das atividades deverá preservar a continuidade dos serviços, evitando-se interrupções injustificadas nos atendimentos, escalas, plantões, rotinas administrativas, ações operacionais e demais atividades necessárias ao funcionamento da rede municipal de saúde.

A execução das demandas dependerá de solicitação formal da Secretaria Municipal de Saúde, compatibilidade com o objeto, disponibilidade financeira, existência de profissionais habilitados e presença das condições estruturais, sanitárias, técnicas, materiais e operacionais necessárias.

As solicitações verbais ou emergenciais deverão ser posteriormente formalizadas, de modo a assegurar sua identificação, rastreabilidade, acompanhamento, validação e inclusão nos relatórios de execução.

As demandas incompletas, incompatíveis com o objeto ou impossibilitadas por ausência de autorização, profissional habilitado, estrutura, material, medicamento, insumo, equipamento, sistema ou condição sanitária adequada deverão permanecer registradas como pendentes, impedidas ou não aptas à execução.

A não execução de uma atividade por fator alheio à atuação da OSCIP deverá ser formalmente justificada e acompanhada das evidências disponíveis, não podendo ser automaticamente considerada descumprimento da meta quando demonstrada a inexistência das condições necessárias.

As atividades interrompidas ou não executadas por impedimento temporário deverão ser reprogramadas dentro da vigência, sempre que possível e desde que permaneçam compatíveis com o objeto e com as prioridades estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A alteração das atividades, dos quantitativos, das escalas ou da distribuição dos recursos poderá ocorrer durante a vigência para atender às necessidades da rede, desde que não resulte em modificação do objeto, ampliação indevida das obrigações, inclusão de despesa estranha ao projeto ou comprometimento das metas aprovadas.

Os quantitativos previstos na planilha de execução direta possuem natureza referencial e estimativa. A mobilização efetiva dos profissionais e prestadores deverá observar as demandas formalizadas, as escalas autorizadas, a disponibilidade financeira e a comprovação dos serviços realizados.

Os pagamentos deverão estar vinculados à execução efetiva das atividades e à apresentação dos documentos fiscais, trabalhistas, assistenciais, administrativos e operacionais aplicáveis.

Os documentos relacionados à execução física e financeira deverão ser organizados e mantidos de forma íntegra, legível e acessível para acompanhamento, fiscalização, auditoria, avaliação e prestação de contas.

Os registros assistenciais deverão ser efetuados nos instrumentos e sistemas definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, preservando-se a continuidade das informações, a identificação profissional e a segurança dos dados.

Os prontuários, documentos clínicos, sistemas de informação e registros dos usuários permanecerão sob responsabilidade institucional da rede municipal de saúde, não podendo ser retirados, copiados, compartilhados ou utilizados para finalidade diversa sem autorização legal e institucional.

O tratamento de dados pessoais e informações de saúde deverá observar a legislação de proteção de dados, o sigilo profissional, os princípios da necessidade e da finalidade e as medidas técnicas e administrativas destinadas à prevenção de acessos indevidos, perdas, vazamentos ou usos inadequados.

A OSCIP deverá comunicar formalmente à Secretaria Municipal de Saúde quaisquer ocorrências que possam comprometer as metas, os prazos, a segurança assistencial, a regularidade das escalas, a disponibilidade dos profissionais ou a adequada utilização dos recursos.

As irregularidades, inconsistências ou falhas identificadas durante o acompanhamento deverão ser objeto de análise, registro e adoção de medidas corretivas, com definição de responsáveis e prazos para regularização.

A fiscalização municipal poderá solicitar documentos, informações, esclarecimentos, correções, substituições ou providências necessárias à verificação da execução e ao cumprimento das obrigações pactuadas.

Os serviços deverão ser prestados com respeito à dignidade, à integridade, à autonomia, à privacidade, à equidade e aos direitos dos usuários, sendo vedada qualquer forma de discriminação, constrangimento, favorecimento pessoal ou tratamento inadequado.

A execução deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, transparência, integralidade, humanização, segurança e supremacia do interesse público.

As situações não previstas neste Plano de Trabalho deverão ser analisadas conjuntamente pelas partes, formalizadas por escrito e resolvidas conforme a legislação aplicável, as disposições do Termo de Parceria e o interesse público.

Ao término da vigência, deverão ser apresentados o relatório final de execução, a consolidação das metas e indicadores, a relação das atividades realizadas, a demonstração dos resultados alcançados e a documentação necessária à prestação de contas.

A execução do projeto será considerada concluída após o encerramento das atividades, a apresentação dos relatórios e documentos exigidos, a análise da execução física e financeira e o cumprimento das providências eventualmente determinadas pela Administração Pública.

11. LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

O Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal será executado no Município de Dom Aquino/MT, nas unidades, estabelecimentos, serviços, setores administrativos e demais locais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme as demandas formalmente apresentadas e as atividades previstas neste Plano de Trabalho.

As atividades também poderão ser realizadas em outros espaços públicos municipais, comunidades urbanas e rurais, domicílios, locais de atendimento, veículos de transporte sanitário e ambientes externos vinculados às ações da Secretaria Municipal de Saúde, desde que exista solicitação formal, compatibilidade com o objeto e condições técnicas, sanitárias e operacionais adequadas.

Os atendimentos domiciliares, as atividades territoriais, os deslocamentos e as ações externas deverão observar os fluxos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, as atribuições dos profissionais envolvidos, as condições de segurança e os registros necessários à comprovação da execução.

As atividades administrativas, de planejamento, coordenação, supervisão, monitoramento, consolidação de informações, faturamento e prestação de contas poderão ser realizadas nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, da entidade parceira ou em outro local previamente definido entre as partes.

O prazo de execução do projeto será de 180 dias consecutivos e ininterruptos, correspondente a seis meses, contado a partir da data estabelecida na ordem, autorização ou comunicação formal de início das atividades.

Durante esse período, as ações serão executadas de forma contínua, conforme as demandas da rede municipal, as escalas, os cronogramas, a capacidade instalada das unidades, a disponibilidade de profissionais e recursos e as condições necessárias ao cumprimento das metas.

O início das atividades ficará condicionado à formalização do Termo de Parceria, à autorização do Município, à disponibilização dos recursos e à definição dos responsáveis, fluxos e instrumentos necessários à execução e ao acompanhamento do projeto.

Os prazos específicos das atividades poderão variar conforme a natureza, a prioridade, a complexidade e as condições de execução de cada demanda, sem ultrapassar o período de vigência estabelecido.

As demandas não concluídas por impedimento temporário poderão ser reprogramadas dentro dos 180 dias, desde que permaneçam compatíveis com o objeto, possuam condições de execução e sejam formalmente autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Qualquer alteração do prazo dependerá de justificativa técnica e administrativa, manifestação das partes e formalização por instrumento próprio, observadas a legislação aplicável, a disponibilidade de recursos e o interesse público.

O término da vigência não afasta a obrigação de apresentação dos relatórios finais, documentos comprobatórios, consolidação das metas, demonstração dos resultados e prestação de contas referentes às atividades executadas durante o período.

12. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho, será vinculado ao Termo de Parceria, após análise técnica quanto à sua compatibilidade com o Termo de Referência, às diretrizes do município e à legislação aplicável, especialmente a Lei Federal nº 9.790/1999, o Decreto Federal nº 3.100/1999 e Lei Estadual nº 11.082/2020, será formalmente aprovado e homologado pelas partes, para fins de execução.

A aprovação do presente instrumento atesta a adequação das metas, atividades, metodologia, cronograma de execução e previsão de custos, bem como sua conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Por estarem de acordo, as partes firmam o presente Plano de Trabalho, comprometendo-se com sua fiel execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas, nos termos pactuados no Termo de Parceria.

Iredir Maria Laccal da Silva Ferreira

Presidente

ANEXO I

EXECUÇÃO DIRETA DO PROJETO

Atividade	Descrição	Contrato/ Vínculo	Tipo	Proventos	Provisão	Encargos	Valor Unitário
Técnico Enfermagem	Profissional para prestar assistência de enfermagem sob orientação e supervisão do enfermeiro, realizar administração de medicamentos, curativos, verificação de sinais vitais, coleta de materiais, preparação e acompanhamento de usuários, apoio aos procedimentos, organização dos materiais e equipamentos e registros da assistência prestada, observando os protocolos, as normas de biossegurança e os limites legais da categoria.	CLT	Mensal	R\$ 3.760,82	R\$ 731,10	R\$ 1.877,62	R\$ 6.369,55
Técnico Radiologia	Profissional para executar exames e procedimentos radiológicos compatíveis com sua habilitação, preparar e posicionar os usuários, operar equipamentos, aplicar medidas de proteção radiológica, processar e organizar imagens e registros, controlar materiais e comunicar intercorrências, observando as normas técnicas, sanitárias, de biossegurança e de proteção contra radiações.	CLT	Mensal	R\$ 6.946,02	R\$1.350,31	R\$ 3.467,86	R\$ 11.764,19
Técnico Saúde Bucal	Profissional para prestar apoio técnico às atividades de saúde bucal, auxiliar o cirurgião-dentista durante os procedimentos, realizar ações preventivas e educativas, preparar e	CLT	Mensal	R\$ 2.673,28	R\$ 519,69	R\$ 1.334,66	R\$ 4.527,63

	organizar o ambiente e os instrumentos, executar atividades permitidas pela legislação sob supervisão profissional, acompanhar os controles de esterilização e materiais e participar de ações coletivas de promoção da saúde bucal						
Vigia Noturno	Profissional para executar atividades de vigilância patrimonial no período noturno, realizar rondas preventivas, controlar o acesso aos prédios e áreas autorizadas, observar movimentações e condições de segurança, comunicar ocorrências e zelar pelas instalações, veículos, equipamentos, materiais e demais bens vinculados às unidades de saúde	CLT	Mensal	R\$ 2.458,14	R\$ 477,86	R\$ 1.227,25	R\$ 4.163,25

Atividade	Descrição	Tipo	Valor Unitário do Serviço
Serviço de Acompanhamento de Paciente	Pessoa jurídica para realizar acompanhamento e apoio ao paciente durante deslocamentos, consultas, exames, internações, transferências e permanência em unidades de saúde, auxiliando na mobilidade, orientação, acomodação, alimentação e organização de documentos, conforme as condições do usuário e orientações da equipe responsável, sem execução de atos privativos dos profissionais de saúde.	Serviço Mensal	R\$ 2.500,00
Serviço de Agente de Conservação e Limpeza II	Pessoa jurídica para executar atividades de limpeza, higienização, desinfecção, conservação e organização das áreas internas e externas das unidades de saúde, incluindo consultórios, recepções, corredores, sanitários, salas administrativas e demais ambientes, observando os protocolos de biossegurança e o gerenciamento adequado dos resíduos dos serviços de saúde.	Serviço Mensal	R\$ 1.800,00

Atividade	Descrição	Tipo	Valor Unitário do Serviço
Serviço de Assistente Social	Pessoa jurídica devidamente habilitada para realizar acolhimento, atendimento, orientação e acompanhamento social dos usuários e de suas famílias, identificando situações de vulnerabilidade, realizando encaminhamentos à rede de proteção e elaborando registros, relatórios, estudos e pareceres dentro de sua competência profissional.	Serviço Mensal	R\$ 3.300,00
Serviço de Auxiliar de Saúde Bucal	Pessoa jurídica devidamente habilitada para prestar apoio ao cirurgião-dentista na preparação do ambiente, paciente, instrumentos, materiais e equipamentos, auxiliar durante os procedimentos odontológicos, realizar limpeza e acondicionamento dos instrumentos, organizar registros e participar de ações educativas e preventivas.	Serviço Mensal	R\$ 2.400,00
Serviço de Bioquímico I	Pessoa jurídica devidamente habilitada para executar atividades laboratoriais relacionadas à coleta, identificação, processamento, análise e controle de qualidade de amostras biológicas, acompanhar equipamentos, reagentes e insumos e manter os registros técnicos, observadas as normas profissionais e de biossegurança.	Serviço Mensal	R\$ 5.112,00
Serviço de Controlador de Frota	Pessoa jurídica para organizar, controlar e acompanhar a utilização dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, mantendo registros de itinerários, quilometragem, abastecimento, manutenção, documentação e ocorrências, bem como apoiando a programação do transporte sanitário.	Serviço Mensal	R\$ 4.000,00
Serviço de Controlador de Frota – Plantão	Plantão a ser realizado por pessoa jurídica para atendimento, conforme demanda, das rotinas de controle e acompanhamento da frota, incluindo registros de veículos e deslocamentos, apoio à programação dos transportes, comunicação de ocorrências e acompanhamento das demandas emergenciais ou extraordinárias.	Conforme Demanda	R\$ 129,03
Serviço de Coordenador Administrativo	Pessoa jurídica para prestar apoio à organização, coordenação e acompanhamento das atividades administrativas vinculadas ao projeto, incluindo controle de documentos, demandas, escalas, prazos, registros, relatórios, processos internos e consolidação de informações necessárias ao monitoramento e prestação de contas.	Serviço Mensal	R\$ 5.200,00
Serviço de Coordenador Administrativo – Plantão	Plantão a ser realizado por pessoa jurídica para atendimento, conforme demanda, das necessidades de organização e acompanhamento administrativo, incluindo apoio à gestão de	Conforme Demanda	R\$ 190,00

	escalas, demandas, fluxos, ocorrências, registros e informações necessárias à continuidade das atividades das unidades e serviços de saúde.		
Atividade	Descrição	Tipo	Valor Unitário do Serviço
Serviço de Coordenador de Unidade de Saúde	Pessoa jurídica para apoiar a organização e o acompanhamento das rotinas administrativas, assistenciais, operacionais e logísticas da unidade, incluindo agendas, escalas, fluxos de atendimento, utilização dos espaços, condições de funcionamento, registros e relatórios, sem substituição das competências da gestão municipal.	Serviço Mensal	R\$ 6.000,00
Serviço de Dentista	Pessoa jurídica devidamente habilitada para realizar avaliação, diagnóstico, prevenção, tratamento e acompanhamento das condições de saúde bucal, executar procedimentos odontológicos, realizar prescrições e encaminhamentos quando necessários e participar de ações educativas e preventivas.	Serviço Mensal	R\$ 4.770,00
Serviço de Educador Físico I	Pessoa jurídica devidamente habilitada para planejar, orientar e acompanhar atividades físicas e práticas corporais voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças, envelhecimento ativo e melhoria da capacidade funcional dos usuários.	Serviço Mensal	R\$ 3.300,00
Serviço de Enfermeiro	Pessoa jurídica devidamente habilitada para realizar consulta, avaliação, planejamento e execução dos cuidados de enfermagem, prestar assistência aos usuários, executar procedimentos próprios da profissão, orientar a equipe e registrar a assistência prestada.	Serviço Mensal	R\$ 4.770,00
Serviço de Enfermeiro Diurno	Pessoa jurídica devidamente habilitada para executar as atribuições próprias do enfermeiro durante o período diurno, coordenando e supervisionando a assistência, acompanhando os usuários, organizando procedimentos e assegurando a continuidade dos cuidados durante o turno.	Serviço Mensal	R\$ 4.950,00
Serviço de Enfermeiro Noturno	Pessoa jurídica devidamente habilitada para executar as atribuições próprias do enfermeiro durante o período noturno, realizar e receber passagem de plantão, acompanhar usuários, atuar nas intercorrências e assegurar a continuidade e segurança da assistência.	Serviço Mensal	R\$ 5.200,00
Serviço de Enfermeiro – Plantão	Plantão a ser realizado por pessoa jurídica devidamente habilitada para prestar assistência de enfermagem conforme demanda, incluindo avaliação dos usuários, execução e supervisão dos	Conforme Demanda	R\$ 159,00

	cuidados, acompanhamento de intercorrências, registros assistenciais e continuidade do atendimento durante o período designado.		
Atividade	Descrição	Tipo	Valor Unitário do Serviço
Serviço Farmacêutico	Pessoa jurídica devidamente habilitada para executar e acompanhar as atividades de assistência farmacêutica, incluindo recebimento, armazenamento, controle, distribuição e dispensação de medicamentos e insumos, orientação aos usuários e controle de estoque, validade e rastreabilidade.	Serviço Mensal	R\$ 4.770,00
Serviço de Fisioterapeuta	Pessoa jurídica devidamente habilitada para realizar avaliação fisioterapêutica, diagnóstico funcional, planejamento e execução do tratamento e desenvolver ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da capacidade funcional.	Serviço Mensal	R\$ 3.862,16
Serviço Médico Clínico – Plantão 12h	Plantão de 12 horas a ser realizado por pessoa jurídica devidamente habilitada para prestar atendimento médico, realizar avaliação, diagnóstico, prescrição, acompanhamento, observação, estabilização e encaminhamento dos usuários e atuar nas intercorrências compatíveis com a capacidade da unidade.	Conforme Demanda	R\$ 1.400,00
Serviço Médico Clínico Geral	Pessoa jurídica devidamente habilitada para realizar consultas médicas, avaliação clínica, diagnóstico, tratamento, prescrição, solicitação e interpretação de exames, acompanhamento dos usuários e encaminhamento para outros serviços quando necessário.	Serviço Mensal	R\$ 19.500,00
Serviço de Motorista I	Pessoa jurídica para conduzir veículos vinculados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, transportando equipes, documentos, materiais, medicamentos, insumos e equipamentos e realizando deslocamentos conforme programação autorizada.	Serviço Mensal	R\$ 2.400,00
Serviço de Motorista II	Pessoa jurídica para conduzir veículos destinados ao transporte de pacientes, equipes e materiais, inclusive em trajetos intermunicipais ou de maior complexidade operacional, mantendo registros das viagens e zelando pela segurança e conservação do veículo.	Serviço Mensal	R\$ 2.600,00
Serviço de Motorista – Plantão	Plantão a ser realizado por pessoa jurídica para atendimento, conforme demanda, das necessidades de transporte de pacientes, equipes, materiais, medicamentos, documentos ou equipamentos, observadas a programação autorizada e as normas de trânsito e segurança.	Conforme Demanda	R\$ 87,00

Atividade	Descrição	Tipo	Valor Unitário do Serviço
Serviço de Psicólogo I	Pessoa jurídica devidamente habilitada para realizar acolhimento, avaliação, atendimento psicológico, orientação e acompanhamento individual ou coletivo dos usuários e desenvolver ações de promoção da saúde mental e apoio aos familiares.	Serviço Mensal	R\$ 3.300,00
Serviço de Psicólogo II	Pessoa jurídica devidamente habilitada para executar atividades psicológicas de maior abrangência ou complexidade, incluindo avaliação, acompanhamento continuado, intervenções individuais e coletivas, elaboração de documentos técnicos e articulação com a rede de atenção psicossocial.	Serviço Mensal	R\$ 5.066,16
Serviço de Recepcionista II	Pessoa jurídica para realizar acolhimento inicial, recepção, identificação e orientação dos usuários, organizar filas, agendas, documentos, prontuários e encaminhamentos e prestar apoio ao fluxo de atendimento das unidades de saúde.	Serviço Mensal	R\$ 1.800,00
Serviço de Recepcionista III	Pessoa jurídica para executar atividades ampliadas de recepção e apoio administrativo, incluindo acolhimento, organização de agendas e prontuários, atualização cadastral, controle de documentos, encaminhamento dos usuários e apoio à alimentação de sistemas.	Serviço Mensal	R\$ 2.000,00
Serviço de Recepcionista IV	Pessoa jurídica para executar atividades de recepção e apoio administrativo de maior responsabilidade, auxiliando na organização das rotinas, acompanhamento dos fluxos, conferência de documentos e consolidação das informações administrativas.	Serviço Mensal	R\$ 2.200,00
Serviço de Recepcionista – Plantão	Plantão a ser realizado por pessoa jurídica para atendimento, conforme demanda, das rotinas de recepção, acolhimento, orientação, registro e encaminhamento dos usuários e apoio aos fluxos administrativos das unidades de saúde.	Conforme Demanda	R\$ 67,00
Serviço de Serviços Gerais III	Pessoa jurídica para executar atividades ampliadas de apoio operacional, limpeza, conservação, organização, movimentação de materiais e equipamentos, preparação dos ambientes, recolhimento e acondicionamento de resíduos e demais ações necessárias ao funcionamento das unidades de saúde.	Serviço Mensal	R\$ 1.800,00
Serviço de Serviços Gerais – Plantão	Plantão a ser realizado por pessoa jurídica para execução, conforme demanda, de atividades de limpeza, conservação, organização dos ambientes, movimentação de materiais e demais ações operacionais necessárias ao funcionamento das unidades e serviços de saúde.	Conforme Demanda	R\$ 60,00

Serviço Técnico Administrativo II	Pessoa jurídica para executar atividades administrativas de apoio às unidades e serviços de saúde, incluindo organização de documentos, formulários, planilhas, controles, arquivos, agendas e relatórios, alimentação de sistemas, acompanhamento de demandas e conferência de informações.	Serviço Mensal	R\$ 2.534,82
Serviço Técnico Administrativo II – Plantão	Plantão a ser realizado por pessoa jurídica para execução, conforme demanda, de atividades administrativas, incluindo organização e conferência documental, registros, atualização de controles, alimentação de sistemas, acompanhamento de solicitações e apoio aos fluxos internos das unidades de saúde.	Conforme Demanda	R\$ 87,00

A tabela apresentada neste Anexo demonstra as atividades previstas para a execução direta do Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal, contendo a forma de contratação, o tipo de execução, os quantitativos referenciais, os valores unitários, os valores mensais e os valores correspondentes com vigência a partir de 01 de agosto de 2026.

A estrutura referencial contempla atividades técnicas, assistenciais, administrativas, operacionais e logísticas relacionadas ao funcionamento das unidades municipais de saúde, à Atenção Primária, à assistência hospitalar, à reabilitação, à assistência farmacêutica, à saúde bucal, ao apoio psicossocial, ao transporte sanitário, à recepção, à conservação, à higienização e às demais ações regulares da Secretaria Municipal de Saúde.

Os quantitativos e valores apresentados possuem natureza referencial e estimativa, destinando-se ao dimensionamento da estrutura necessária ao cumprimento das metas e dos resultados estabelecidos no Plano de Trabalho. Sua indicação não caracteriza criação de cargos públicos, fornecimento ou cessão de mão de obra, contratação direta de pessoal pelo Município ou obrigação de manutenção de postos fixos sob subordinação da Administração Pública.

As descrições das atividades possuem caráter referencial e orientativo, destinando-se a estabelecer seus limites, responsabilidades e resultados esperados. A execução deverá observar a natureza complementar da parceria, as metas e os indicadores do projeto, as solicitações formalizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e as competências legalmente reservadas aos agentes públicos e aos profissionais habilitados.

As atribuições deverão ser interpretadas em conjunto com os objetivos, as metas, a metodologia, o cronograma de execução e os mecanismos de acompanhamento e avaliação previstos no Plano de Trabalho. Poderão ocorrer ajustes operacionais nas atividades conforme as demandas efetivamente apresentadas, desde que sejam preservados o objeto, os limites de atuação, as qualificações necessárias e os resultados pactuados.

A execução dessas atividades deverá contribuir para a continuidade e o fortalecimento dos serviços regulares de saúde, para o funcionamento das unidades urbanas e rurais, para a manutenção dos atendimentos médicos, de enfermagem, odontológicos, laboratoriais, farmacêuticos, psicológicos, fisioterapêuticos, administrativos e operacionais e para a melhoria da organização, da segurança e da qualidade da assistência prestada durante o período de vigência do projeto.

Os relatórios de execução deverão demonstrar as atividades realizadas, as unidades e serviços atendidos, as escalas cumpridas, os profissionais mobilizados, os atendimentos e procedimentos executados, os deslocamentos efetuados, os materiais, medicamentos, insumos e equipamentos utilizados, as ocorrências identificadas, as providências adotadas, os resultados alcançados e a comprovação da adequada aplicação dos recursos vinculados ao projeto.

ANEXO II

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Classificação	Valor Rateio Sec + TP	Valor Rateio Sede	Valor Mensal
Auditoria Independente (Em atendimento à Lei Federal nº 9.790/1999, ao Decreto nº 3.100/1999 e à Lei Estadual nº 11.082/2020, que estabelecem a obrigatoriedade de auditoria externa por profissional/empresa habilitada para análise da execução dos Termos de Parceria quando o valor pactuado for igual ou superior a R\$ 600.000,00.)	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Despesa com Imóvel (Despesas com Locação de Imóvel, Fornecimento de Água e Energia Elétrica, Internet/Telefone, Manutenção Predial e Afins)	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Despesas Bancárias (Despesas com Tarifa Manutenção Mensal, Tarifas Transferências Bancárias e Afins)	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
Despesas Pessoa Física e Jurídica (Despesas com Honorários Advocatícios e Contábeis, Contratação de Prestadores e/ou Profissionais nas Áreas: Administrativa, Financeira, Projetos, Faturamento, TI, Verificação Independente, Gestão, Locação de Veículo(s) e Impressora(s), Diária(s), Deslocamento e Afins)	R\$ 73.727,22	R\$ 30.000,00	R\$ 103.727,22
Materiais de Consumo e Expediente (Despesa com Materiais de Uso na Rotina Administrativa, Limpeza, Copa e Afins)	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 800,00
Total			R\$ 115.627,22

Secretaria/Programa	Valor Mensal Total	% Rateio	Valor Rateio Mensal
Secretaria de Administração	R\$ 67.218,41	5,67%	R\$ 6.553,80
Secretaria de Agricultura	R\$ 8.200,00	0,69%	R\$ 799,50
Secretaria de Assistência Social e Habitação	R\$ 187.709,99	15,83%	R\$ 18.301,72
Secretaria de Chefia de Gabinete	R\$ 4.500,00	0,38%	R\$ 438,75
Secretaria de Cultura	R\$ 9.300,00	0,78%	R\$ 906,75
Secretaria de Educação	R\$ 182.557,47	15,39%	R\$ 17.799,35
Secretaria de Esporte e Lazer	R\$ 16.415,77	1,38%	R\$ 1.600,54
Secretaria de Obras Públicas e Urbanismo	R\$ 227.082,50	19,15%	R\$ 22.140,54
Secretaria de Saúde	R\$ 440.013,38	37,10%	R\$ 42.901,31
Departamento de Água e Esgoto – DAE	R\$ 42.922,65	3,62%	R\$ 4.184,96
Total	R\$ 1.185.920,16	100%	R\$ 115.627,22

Para fins de organização, controle, execução financeira e prestação de contas, as despesas administrativas e operacionais serão classificadas nas seguintes categorias:

- **Auditoria Independente**

Compreende as despesas destinadas à contratação de auditoria externa, realizada por empresa legalmente habilitada, para análise contábil e documental do Termo de Parceria.

A auditoria independente será realizada em atendimento à Lei Federal nº 9.790/1999, ao Decreto Federal nº 3.100/1999 e à Lei Estadual nº 11.082/2020, observada a obrigatoriedade aplicável aos Termos de Parceria cujo valor pactuado seja igual ou superior a R\$ 600.000,00.

O serviço avaliará a regularidade da aplicação dos recursos, a compatibilidade das despesas com o objeto pactuado, a adequação dos registros contábeis e financeiros e o cumprimento das obrigações relacionadas à execução e à prestação de contas da parceria.

- **Despesas com Imóvel**

Compreendem as despesas necessárias à manutenção da estrutura física da sede da organização e unidade local, utilizada para a gestão administrativa e operacional da parceria, incluindo locação de imóvel, fornecimento de água, energia elétrica, internet, telefone, manutenção predial e demais custos correlatos.

Quando o imóvel ou a estrutura for utilizado simultaneamente em outras atividades da OSCIP, as despesas deverão ser apropriadas proporcionalmente, mediante critério objetivo e demonstrável, vedada a atribuição integral de custos compartilhados ao projeto sem justificativa.

- **Despesas Bancárias**

Compreendem as despesas diretamente relacionadas à manutenção e à movimentação da conta bancária específica do Termo de Parceria, incluindo tarifas de manutenção mensal, transferências bancárias, emissão de documentos, pagamentos e demais serviços financeiros necessários à execução.

As despesas deverão estar identificadas nos extratos bancários e vinculadas à movimentação financeira dos recursos da parceria.

- **Despesas com Pessoa Física e Jurídica**

Compreendem as despesas decorrentes da contratação de pessoas físicas ou jurídicas necessárias ao suporte administrativo, técnico, financeiro, jurídico, contábil, operacional e gerencial da parceria.

Poderão integrar essa rubrica os honorários advocatícios e contábeis, bem como a contratação de prestadores ou profissionais para atuação nas áreas administrativa, financeira, projetos, faturamento, tecnologia da informação, recursos humanos, verificação independente, gestão, monitoramento, prestação de contas e demais atividades de apoio relacionadas à execução.

Também poderão ser incluídas, quando necessárias e devidamente justificadas, despesas com locação de veículos, locação de impressoras, diárias, deslocamentos e outros serviços indispensáveis ao desenvolvimento, acompanhamento e fiscalização das ações previstas.

As contratações observarão critérios de necessidade, compatibilidade com o objeto, razoabilidade dos valores, capacidade técnica dos prestadores e efetiva comprovação dos serviços realizados.

- **Materiais de Consumo e Expediente**

Compreendem as despesas com materiais utilizados na rotina administrativa e operacional da parceria, incluindo materiais de expediente, papelaria, impressão, organização documental, limpeza, copa e demais itens de consumo necessários ao desenvolvimento das atividades.

As aquisições deverão ocorrer em quantidade compatível com as necessidades do projeto, estar vinculadas às ações previstas e ser comprovadas por documentos fiscais e registros de recebimento e utilização.

13. FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO – TERMO DE PARCERIA Nº 001/2026

Projeto: Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal

Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

Município: Dom Aquino/MT

Entidade Parceira: Organização de Saúde São Bento

CNPJ: 45.603.168/0001-20

13.1. OBJETO DA APROVAÇÃO

O presente formulário tem por finalidade registrar a análise e aprovação da alteração do ANEXO I – EXECUÇÃO DIRETA DO PROJETO, integrante do Plano de Trabalho vinculado ao Termo de Parceria nº 001/2026, referente ao Projeto FORSAÚDE – Fortalecimento da Saúde Pública Municipal, executado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

A alteração apresentada restringe-se exclusivamente ao **Anexo I**, contemplando a atualização e adequação do quadro de atividades destinadas à execução direta do projeto, com revisão das nomenclaturas, descrições, tipos de execução e valores unitários dos serviços previstos, incluindo a adequação e inclusão de atividades executadas conforme demanda/plantão.

13.2. RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Fica expressamente registrado que todas as demais informações e disposições constantes no Plano de Trabalho permanecem inalteradas, não havendo modificação do objeto, das metas, da metodologia, do cronograma de execução, do prazo de vigência, dos resultados esperados e das demais condições anteriormente aprovadas.

Permanecem, portanto, integralmente ratificadas e vigentes as demais disposições do Plano de Trabalho vinculado ao Termo de Parceria nº 001/2026.

3. MANIFESTAÇÃO

Após análise da alteração apresentada:

☐ **APROVADO**

☐ **APROVADO COM RESSALVAS**

☐ **NÃO APROVADO**

Ressalvas/Observações, se houver:

Dom Aquino/MT, _____ de _____ de 2026.



RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

Nome: _____

Cargo/Função: _____

Assinatura: _____